3.3

院内高级生命支持团队知识拓展

05 院内高级生命支持（ALS）

为什么要设置“超出学生能力范围”的知识拓展?

- 建立“急救链条”的完整认知。
  - 生死战斗才刚刚开始。
- 实现“角色代入”的职业启蒙。
- 衔接“院前”与“院内”，构建知识梯度。

使用‘华西医院’作为案例

→ 能让学生产生“这是真的、这是重要的”认知。

院内高级生命支持团队揭秘

从现场到医院：生命接力的完整链条

我们此前所学的院前急救技能，构成了生命抢救链条中的初始环节——现场第一反应。当患者被转运至医院急诊科后，救治工作便由一支专业化、体系化的高级生命支持团队接管。

急诊医生
抢救现场的"指挥官"

- 快速评估、下达关键医嘱
- 执行高级气道管理（如气管插管）
- 决定核心治疗方案

华西医院示例：细分亚专业学组（危重症急救、中毒、创伤等）

急诊护士
治疗的"执行官"与"监护官"

- 建立输液的"生命通道"
- 管理各类救命药物
- 持续监测生命体征

华西医院：180+专业护理人员，近半数为急诊急救专科护士

急诊ICU团队
危重患者的"守护神"

- 提供24小时不间断深度监护和治疗
- 开展ECMO（人工肺）、CRRT（人工肾）等终极生命支持

关键作用：与死神最直接的拉锯战

多学科支援团队
强大的"后援军团"

- 重症医学科（ICU）专家
- 心血管、神经内科等专科医生
- 临床药师、营养师
- 呼吸治疗师、CRRT专项护士

完整链条：现场基础生命支持（BLS）→ 院前急救 → 院内高级生命支持（ALS）→ 康复。我们的急救技能，为专业救治创造了宝贵的机会。